ÁGORA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

PROTOCOLOS DE LIBERACIÓN DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA

Autores: Tecnicas grupo B *Docente: Leonardo Arzayus Patiño*
Curso:Tecnicas de intervención en fisioterapia II Semestre: séptimo

Introducción

El destete ventilatorio consiste en retirar progresivamente la ventilación mecánica para recuperar la respiración espontánea. Se clasifica en simple y prolongado según la dificultad del proceso.

Planteamiento del problema

El uso prolongado de ventilación mecánica invasiva puede generar debilidad muscular respiratoria y dependencia ventilatoria, dificultando su retiro. Por ello, es necesario identificar estrategias que permitan una liberación segura e individualizada.

Metodología

Se realizó una revisión descriptiva de literatura científica en PubMed, Scopus, SciELO, Cochrane Library y Springer Nature durante octubre de 2026.

Resultados

Destete ventilatorio simple

Se logra superar la primera prueba de respiración espontánea.

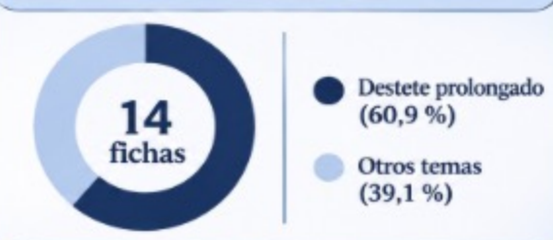


Principales estrategias

- Evaluación diaria
- Prueba de respiración espontánea
- Presión de soporte (PSV)
- Pieza en T
- Evaluación preextubación

Destete ventilatorio prolongado

Se presenta cuando el paciente necesita varios intentos o más tiempo para el proceso.



Principales estrategias

- Reducción de presión de soporte
- Respiración espontánea
- Entrenamiento muscular inspiratorio
- Manejo de secreciones
- Asistencia de la tos
- Intervención individualizada

Discusión

El destete requiere una progresión según la estabilidad y tolerancia del paciente. La presión de soporte y la pieza en T son métodos utilizados, sin superioridad concluyente entre ellos. El entrenamiento muscular inspiratorio, la movilización temprana y el manejo de secreciones complementan la intervención fisioterapéutica.

Conclusión

La liberación ventilatoria requiere un abordaje interdisciplinario e individualizado. La fisioterapia favorece este proceso mediante la evaluación respiratoria, el entrenamiento muscular y la recuperación funcional.

Bibliografías QR

ODS